HITTA PUNKTEN OCH VET VAD DU SKA GÖRA™

60 Behandlingsprotokoll per Muskel

Atlasen visar dig var punkten sitter. Den här guiden visar vad du gör med den: läge, teknik, stretch, dos och hemuppgift, muskel för muskel.

Triggerpunktsatlas · Utbildningsmaterial för vårdpersonal och studenter. Ersätter inte medicinsk diagnos.

Innehåll

1 · Allmänna principer

2 · Huvud, ansikte och nacke

3 · Skuldra, överarm, underarm och hand

4 · Rygg, ryggrad och bål

5 · Bäcken, höft och säte

6 · Lår, underben och fot

Nästa steg

AVSNITT 1

Allmänna principer

Varje protokoll följer den här ordningen.

Vem materialet är för

Utbildningsmaterial för fysioterapeuter, massageterapeuter, osteopater, tränare och studenter inom hälsovetenskap. Protokollen sammanfattar tekniker som ofta används vid manuell behandling av myofasciella triggerpunkter. De ersätter varken medicinsk diagnos eller din egen professionella bedömning.

STEG	VAD DU GÖR	DOSERING
1. Lokalisering	Hitta det spända bandet och den ömmaste punkten i det (enligt kortet i atlasen).	—
2. Ischemisk kompression	Gradvis, stadigt tryck på punkten tills patienten anger ett obehag på ungefär 5–7 på skalan 0–10. Följ med djupare allteftersom spänningen släpper.	30–90 s, 3–5 repetitioner
3. Stretch	Långsam och smärtfri stretch av muskeln du har behandlat, på utandningen.	3 × 20–30 s
4. Aktiv rörelse	Patienten rör muskeln några gånger genom hela rörelseomfånget.	3–5 repetitioner
5. Hemuppgift	Ge en enkel stretch eller övning (se slutet av protokollet).	1–2 gånger om dagen

När du INTE behandlar (och remitterar till läkare)

Nylig skada eller svullnad, feber, nattlig smärta utan känd orsak, domningar eller svaghet som inte stämmer med kartan över refererad smärta, misstänkt trombos, hudåkomma i området. Hos en patient som tar blodförtunnande läkemedel använder du bara lätt tryck.

AVSNITT 2

Huvud, ansikte och nacke

12 muskler, i atlasens ordning.

1. Trapezius – övre fibrer

Musculus trapezius, pars descendens

VAR DU LETAR	Ovanför skuldergördeln, mitt emellan nacken och akromion, i den övre fria kanten.
REFERERAD SMÄRTA	tinningen, huvudets sida, halsens sida, bakom örat, underkäksvinkeln
PATIENT	Ryggliggande eller sittande, armarna avslappnade i knät.
TEKNIK	• Pincettgrepp om de övre fibrerna (tumme och pekfinger), ihållande ischemisk kompression på det spända bandet. • Alternativt: platt tryck med fingertopparna ovanför skuldergördeln.
STRETCH	Huvudet lutas mot motsatt sida med lätt flexion; sittande håller patienten tag under stolen med handen på samma sida.
DOS	3–5 × 30–90 s kompression, därefter 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Lateralflexionsstretch två gånger om dagen; skärmen i ögonhöjd; ingen mobil mellan örat och axeln.

2. Sternocleidomastoideus (SCM)

Musculus sternocleidomastoideus

VAR DU LETAR	Längs muskelbuken, särskilt i den sternala och den klavikulära delen; den ömmaste punkten ligger i mittersta tredjedelen.
REFERERAD SMÄRTA	pannan, runt ögat, kinden, djupt i örat, hjässan, bakhuvudet
PATIENT	Ryggliggande, huvudet lätt lutat mot den sida du behandlar så att muskeln slappnar av.
TEKNIK	• Endast pincettgrepp: fatta muskelbuken med två fingrar och lyft den försiktigt bort från halsens djupa strukturer. • Behandla den sternala och den klavikulära delen var för sig, nedifrån och upp.
STRETCH	Huvudet lutas mot motsatt sida och därefter vrids hakan långsamt mot den sida du behandlar; lätt extension endast om det inte ger yrsel.
DOS	3 × 30–60 s kompression med pincettgrepp i varje del, därefter 2–3 × 20 s stretch.
HEMMA	Långsamma rörelser och rotationer av huvudet; inte titta på tv liggande eller läsa med upplyft huvud.

> **Obs!** Halspulsådern (a. carotis) går precis under muskeln: tryck aldrig bakåt på halsens framsida. Vid yrsel, illamående eller synstörning, avbryt omedelbart.

3. Masseter

Musculus masseter

VAR DU LETAR	I det ytliga lagret under arcus zygomaticus och ovanför underkäksvinkeln; i det djupa lagret framför käkleden.
REFERERAD SMÄRTA	kindtänderna i över- och underkäken, underkäken, ögonbrynet, djupt i örat
PATIENT	Ryggliggande, munnen lätt öppen.
TEKNIK	• Extraoralt: platt kompression med fingertopparna under arcus zygomaticus och ovanför käkvinkeln. • Intraoralt (med handske): pincettgrepp, ett finger i munnen och ett utanför; långsam tvärfriktion över fibrerna.
STRETCH	Långsam gapning med tungspetsen mot gommen; terapeutens två fingrar för försiktigt käken nedåt.
DOS	3 × 30–60 s kompression, 2–3 × 20 s stretch.
HEMMA	Daglig självmassage med cirkelrörelser; undvik tuggummi; var uppmärksam på om patienten biter ihop under dagen.

Obs! Vid nytillkommen smärta i käkleden eller tandproblem, först undersökning hos tandläkare. I munnen alltid med handske.

4. Temporalis

Musculus temporalis

VAR DU LETAR	Ovanför arcus zygomaticus i fyra zoner, framifrån och bakåt; palperas lätt när patienten tuggar.
REFERERAD SMÄRTA	tinningen, ögonbrynet, bakom ögat, tänderna i överkäken, huvudets sida
PATIENT	Ryggliggande eller sittande, tänderna lätt isär.
TEKNIK	• Platt kompression med fingertopparna på de fyra fibergrupperna ovanför arcus zygomaticus, framifrån och bakåt. • Långsam tvärfriktion över de spända banden.
STRETCH	Långsam gapning medan terapeutens fingrar glider uppåt över tinningen.
DOS	3 × 30–60 s per punkt, därefter 3–5 långsamma strykningar.
HEMMA	Självmassage av tinningarna när huvudvärken börjar; uppföljning av nattlig tandgnissling.

5. Pterygoideus lateralis

Musculus pterygoideus lateralis

VAR DU LETAR	Djupt under arcus zygomaticus; intraoralt bakom de övre molarerna, uppåt och bakåt.
REFERERAD SMÄRTA	käkleden, kinden (över bihålorna)
PATIENT	Ryggliggande, munnen halvöppen.
TEKNIK	• Intraoralt, med handske: försiktigt, långsamt tryck med lillfingret bakom de övre molarerna. • Extraoralt: kompression i fördjupningen under arcus zygomaticus med öppen mun.
STRETCH	Långsam retraktion av underkäken (patienten drar hakan lätt bakåt) och därefter långsam stängning av munnen.
DOS	2–3 × 20–30 s lätt tryck, 2 × 20 s stretch.
HEMMA	Undvik hård mat och stora tuggor; gapa medvetet långsamt och rakt.

> **Obs!** I munnen arbetar du endast med handske och mycket försiktigt; vid smärtsamt ljud eller ”låsning” i käken, tandläkare eller käkkirurg.

6. Pterygoideus medialis

Musculus pterygoideus medialis

VAR DU LETAR	På insidan av underkäksvinkeln, palpation underifrån; intraoralt bakom den sista molaren.
REFERERAD SMÄRTA	tungroten, halsen (svalget), under örat, käkleden
PATIENT	Ryggliggande, huvudet lätt vridet mot den sida du behandlar.
TEKNIK	• Extraoralt: tryck med fingertopparna uppåt mot insidan av käkvinkeln. • Intraoralt (med handske): försiktigt tryck bakom den sista molaren mot gommen.
STRETCH	Långsam gapning med käken lätt förskjuten mot motsatt sida.
DOS	2–3 × 20–30 s kompression, 2 × 20 s stretch.
HEMMA	Medveten avslappning när patienten biter ihop; mjuk kost under dagar med smärta.

> **Obs!** Vid smärta vid sväljning eller besvär i halsen, först medicinsk undersökning.

7. Splenius capitis

Musculus splenius capitis

VAR DU LETAR	På nackens bakre sida, mellan SCM och trapezius, cirka 2–3 fingerbredder nedanför protuberantia occipitalis externa.
REFERERAD SMÄRTA	hjässan
PATIENT	Ryggliggande eller magliggande, huvudet i mittläge.
TEKNIK	• Platt kompression med fingertopparna i triangeln mellan SCM och trapezius, uppåt och medialt. • Längsgående strykningar mot nackknölen.
STRETCH	Huvudet i flexion och vridet mot motsatt sida.
DOS	3 × 30–60 s kompression, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Undvik att titta uppåt länge (måla, ställa i ordning på hyllor); kudde i rätt höjd.

8. Splenius cervicis

Musculus splenius cervicis

VAR DU LETAR	I nackens nedre del, ovanför skulderbladets övre vinkel, bredvid levator scapulae.
REFERERAD SMÄRTA	bakom ögat, bakhuvudet, övergången nacke–skuldra
PATIENT	Magliggande, med stöd under pannan.
TEKNIK	• Kompression med fingertopparna vid nackens bas, bredvid ryggraden. • Långsam tvärfriktion över det spända bandet.
STRETCH	Huvudet i flexion, med lateralflexion och rotation mot motsatt sida.
DOS	3 × 30–60 s, därefter 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Korrigering av framskjuten huvudhållning; rörelsepaus varje timme.

9. Suboccipitala muskler

Mm. recti capitis posteriores et obliqui capitis

VAR DU LETAR	Precis under nackbenet, till höger och vänster om mittlinjen, på djupet.
REFERERAD SMÄRTA	huvudets sida, bakom ögat, pannan, bakhuvudet
PATIENT	Ryggliggande, terapeuten sitter vid britsens huvudända.
TEKNIK	• Terapeutens fingertoppar under nackbenet; trycket ges av huvudets egen tyngd (suboccipital release). • Vänta tills vävnaden slappnar av och fingrarna sakta sjunker in.
STRETCH	Indragning av hakan (huvudet glider rakt bakåt) och därefter en lätt ”nick” framåt.
DOS	1–2 × 60–120 s release, därefter 5–10 långsamma hakindragningar.
HEMMA	10 hakindragningar om dagen; skärmen i ögonhöjd; kort paus varje timme.

> **Obs!** Vid yrsel, synstörning, domning eller sväljsvårigheter, avbryt omedelbart och remittera patienten till läkare.

10. Semispinalis capitis

Musculus semispinalis capitis

VAR DU LETAR	I nacken, 2–3 cm från mittlinjen, nedanför nackknölen och mitt på nacken.
REFERERAD SMÄRTA	huvudets sida, tinningen, pannan, bakhuvudet
PATIENT	Magliggande eller ryggliggande med huvudet vridet åt sidan.
TEKNIK	• Kompression med fingertopparna bredvid ryggraden, nedifrån och upp. • Längsgående strykningar mot nackknölen.
STRETCH	Huvudet i flexion med lätt rotation åt sidan.
DOS	3 × 30–60 s, därefter 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Undvik framskjuten huvudhållning; vid läsning boken i ögonhöjd.

11. Levator scapulae

Musculus levator scapulae

VAR DU LETAR	Strax medialt om och ovanför skulderbladets övre vinkel; på sidan av nacken, djupt under trapezius övre kant.
REFERERAD SMÄRTA	övergången nacke–skuldra, skulderbladets mediala kant, skuldrans baksida
PATIENT	Magliggande eller sittande, armarna avslappnade.
TEKNIK	• Kompression strax medialt om och ovanför skulderbladets övre vinkel. • Andra punkten: på sidan av nacken, djupt under trapezius övre kant.
STRETCH	Huvudet i flexion och vridet mot motsatt sida (näsan mot armhålan), handen på den behandlade sidan i nacken.
DOS	3–5 × 30–90 s kompression, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Samma stretch två gånger om dagen; undvik hög kudde och vridet huvud i arbetet.

12. Skalenusmusklerna (scaleni)

Mm. scaleni anterior, medius et posterior

VAR DU LETAR	På sidan av halsen, bakom och nedanför SCM, ovanför nyckelbenet.
REFERERAD SMÄRTA	bröstkorgens framsida, överarmen, skulderbladets mediala kant, handen (tumme och pekfinger)
PATIENT	Ryggliggande, huvudet lätt lutat mot den sida du behandlar.
TEKNIK	• Platt, mycket lätt tryck med fingertopparna bakom SCM:s bakre kant, ovanför nyckelbenet. • Korta grepp på 20–30 s; patienten tar djupa bukandetag.
STRETCH	Huvudet lutas mot motsatt sida med lätt extension; terapeuten stabiliserar nyckelbenet på den behandlade sidan nedåt.
DOS	3 × 20–30 s lätt tryck, 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Träning av diafragma- (buk)andning; ingen tung väska på axeln.

> **Obs!** Genom detta område passerar plexus brachialis och blodkärl: om domning eller stickningar strålar ut i armen, minska trycket eller avbryt. Vid ihållande domning, medicinsk undersökning.

AVSNITT 3

Skuldra, överarm, underarm och hand

14 muskler, i atlasens ordning.

13. Infraspinatus

Musculus infraspinatus

VAR DU LETAR	På skulderbladets baksida, under spina scapulae, i mellersta och övre delen av fossa infraspinata.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans framsida (djupt), överarmens främre utsida, underarmen, handens tumsida
PATIENT	Magliggande eller sidliggande med den behandlade sidan uppåt.
TEKNIK	• Platt kompression med fingertopparna eller tummen på skulderbladets baksida. • Arbeta dig punkt för punkt från spina scapulae och nedåt.
STRETCH	Armen på den behandlade sidan förs framför bröstet och den andra handen drar armbågen mot bröstet; eller handen bakom ryggen.
DOS	3–5 × 30–90 s, därefter 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Inte sova på den sida som gör ont; i sidliggande en kudde under armen.

14. Supraspinatus

Musculus supraspinatus

VAR DU LETAR	Ovanför spina scapulae, i den mediala delen av fossa supraspinata och lateralt under akromion.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans sida (deltoideusregionen), överarmens utsida, armbågens utsida
PATIENT	Sittande eller magliggande.
TEKNIK	• Djup kompression med fingertopparna ovanför spina scapulae, genom trapezius fibrer. • Lateralt, nära senan, endast lätt tryck.
STRETCH	Armen på den behandlade sidan bakom ryggen, den andra handen drar försiktigt handleden mot motsatt sida.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Undvik att lyfta tunga föremål över huvudet; dagliga axelcirklar.

Obs! Akut huggande smärta i axeln eller nattlig smärta som inte går över: medicinsk undersökning för att utesluta rotatorkuffskada.

15. Teres minor

Musculus teres minor

VAR DU LETAR	Vid skulderbladets laterala kant, nedanför infraspinatus, ovanför det bakre armhålsvecket.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans baksida (punktformigt), överarmens baksida
PATIENT	Magliggande eller sidliggande, med armen hängande över britsens kant.
TEKNIK	• Pincettgrepp eller kompression med tummen vid skulderbladets laterala kant, ovanför det bakre armhålsvecket.
STRETCH	Armen förs framför bröstet, armbågen dras mot bröstet.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Som för infraspinatus; inte sova med armen över huvudet.

16. Subscapularis

Musculus subscapularis

VAR DU LETAR	På skulderbladets framsida; du når den från armhålan, längs skulderbladets laterala kant.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans baksida, skulderbladet, överarmens baksida, handleden
PATIENT	Ryggliggande, armen i cirka 45° abduktion och utåtrotation.
TEKNIK	• Från armhålan, med fingertopparna mot skulderbladets framsida, mycket långsamt. • Korta grepp, efter patientens signal.
STRETCH	Armen i utåtrotation, armbågen i 90°, handflatan förs försiktigt bakåt (mot dörrkarmen).
DOS	2–3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Övningar för utåtrotation; armen ska inte hållas tryckt mot bålen länge.

Obs! Genom armhålan passerar kärl och nerver: arbeta långsamt och försiktigt; om domning uppstår, minska trycket.

17. Deltoideus

Musculus deltoideus

VAR DU LETAR	I de främre, mellersta och bakre fibrerna, 2–5 cm nedanför akromion.
REFERERAD SMÄRTA	skuldran (runt punkten), överarmen
PATIENT	Sittande eller ryggliggande.
TEKNIK	• Platt kompression eller pincettgrepp separat i var och en av de tre fibergrupperna. • Tvärfriktion över de spända banden.
STRETCH	Främre fibrer: armen bakåt; bakre fibrer: armen förs framför bröstet.
DOS	3 × 30–60 s i varje fibergrupp, 2–3 × 20 s stretch.
HEMMA	Pauser vid upprepade lyftmoment.

18. Pectoralis major

Musculus pectoralis major

VAR DU LETAR	I bröstmuskelns laterala kant (främre armhålsvecket), under nyckelbenet och bredvid bröstbenet.
REFERERAD SMÄRTA	bröstkorgens framsida, skuldrans framsida, överarmens insida, bröstregionen
PATIENT	Ryggliggande, armen i lätt abduktion.
TEKNIK	• Pincettgrepp i det främre armhålsvecket. • Platt kompression under nyckelbenet och bredvid bröstbenet.
STRETCH	Stretch i dörröppning: underarmen mot karmen, armbågen i axelhöjd, bålen tar långsamt ett steg framåt.
DOS	3 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Korrigering av framåtböjd hållning; axlarna bakåt och nedåt.

> **Obs!** Vid smärta i vänster sida av bröstkorgen, särskilt vid ansträngning, med andnöd eller svettningar: först utesluts hjärtorsak, omedelbart till läkare.

19. Pectoralis minor

Musculus pectoralis minor

VAR DU LETAR	Under processus coracoideus, över 3:e–5:e revbenet, djupt under pectoralis major.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans framsida, bröstkorgen, överarmens insida, handens lillfingersida
PATIENT	Ryggliggande, armarna längs bålen.
TEKNIK	• Platt tryck med fingertopparna under pectoralis major, från armhålan medialt och uppåt. • Korta grepp med långsam andning.
STRETCH	Axlarna bakåt och nedåt; i dörröppningen armbågen ovanför axelhöjd.
DOS	3 × 20–30 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Korrigering av framåtdragen axel; styrketräning av ryggmusklerna.

Obs! Om domning strålar ut i armen, minska trycket.

20. Rhomboideus (major och minor)

Mm. rhomboidei major et minor

VAR DU LETAR	Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, under trapezius.
REFERERAD SMÄRTA	skulderbladets mediala kant, mellan skulderbladen
PATIENT	Magliggande, armarna avslappnade bredvid britsen.
TEKNIK	• Kompression med tummen längs skulderbladets mediala kant, uppifrån och ner. • Tvärfriktion över fibrerna.
STRETCH	Armarna korsas framför kroppen (krama dig själv), ryggen kutar lätt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Stretch av bröstmuskeln (rhomboideus är ofta förlängda och svaga).

21. Serratus anterior

Musculus serratus anterior

VAR DU LETAR	På bröstkorgens sida, under armhålan, i höjd med 5:e–6:e revbenet.
REFERERAD SMÄRTA	bröstkorgens sida, skulderbladets nedre vinkel, överarmens insida
PATIENT	Sidliggande med den behandlade sidan uppåt, armen framåt.
TEKNIK	• Platt tryck med fingertopparna under armhålan, mellan revbenen. • Långsamma strykningar längs revbenen.
STRETCH	Armen bakåt och skulderbladet draget mot ryggraden; med djup inandning.
DOS	3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Vanlig efter hosta och intensiv löpning: öka belastningen gradvis.

Obs! Vid akut sidosmärta som hänger ihop med andningen, feber eller hosta, först medicinsk undersökning.

22. Latissimus dorsi

Musculus latissimus dorsi

VAR DU LETAR	I det bakre armhålsvecket, i höjd med skulderbladets nedre vinkel.
REFERERAD SMÄRTA	skulderbladets nedre vinkel, överarmens bakre insida, ringfinger och lillfinger
PATIENT	Magliggande eller sidliggande, armen lyft över huvudet.
TEKNIK	• Pincettgrepp i det bakre armhålsvecket. • Platt kompression bredvid skulderbladets nedre vinkel.
STRETCH	Armen över huvudet, bålen i lateralflexion mot motsatt sida.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Stretch efter chins och dragövningar.

23. Biceps brachii

Musculus biceps brachii

VAR DU LETAR	I mittersta tredjedelen av överarmens framsida, i båda huvudena.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans framsida, armvecket
PATIENT	Ryggliggande, armbågen lätt böjd.
TEKNIK	• Pincettgrepp om muskelbuken. • Platt kompression i mittersta tredjedelen.
STRETCH	Armbågen sträckt, underarmen i pronation, armen bakåt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Undvik att bära tunga föremål med böjd armbåge.

24. Triceps brachii

Musculus triceps brachii

VAR DU LETAR	På överarmens baksida, i det långa huvudet under armhålan och 4–6 cm ovanför armbågen.
REFERERAD SMÄRTA	skuldrans baksida, armbågens utsida, underarmens baksida
PATIENT	Magliggande med armen hängande eller ryggliggande med armen över huvudet.
TEKNIK	• Pincettgrepp om det långa huvudet. • Platt kompression ovanför armbågen.
STRETCH	Armen över huvudet, armbågen helt böjd, den andra handen trycker den försiktigt bakåt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretch.
HEMMA	Pauser vid gång med kryckor och vid armhävningar.

25. Underarmens extensorer (ECRL, ECRB, extensor digitorum)

Mm. extensores carpi radiales et extensor digitorum

VAR DU LETAR	På underarmens bakre laterala sida, 3–6 cm nedanför armbågen.
REFERERAD SMÄRTA	armbågens utsida, underarmens baksida, handryggen, fingrarna
PATIENT	Sittande, underarmen på bordet, handflatan nedåt.
TEKNIK	• Kompression med tummen på muskelbukarna nedanför armbågen. • Tvärfriktion över muskelbuken (inte över benfästet).
STRETCH	Armbågen sträckt, handleden och fingrarna i flexion, den andra handen drar försiktigt nedåt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Pauser vid musanvändning och skruvande; lätta på greppet.

Obs! Vid svullnad, lokal värme eller nattlig domning, först medicinsk undersökning.

26. Underarmens flexorer

Mm. flexores carpi et digitorum

VAR DU LETAR	På underarmens mediala framsida, 3–6 cm nedanför armbågen.
REFERERAD SMÄRTA	handledens volarsida, handflatan, fingrarnas handflatesida
PATIENT	Sittande, underarmen på bordet, handflatan uppåt.
TEKNIK	• Kompression med tummen på muskelbukarna. • Längsgående strykningar mot handleden.
STRETCH	Armbågen sträckt, handflatan uppåt, fingrarna dras bakåt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretch.
HEMMA	Pauser vid manuellt arbete (trädgård, montering); lätta på greppet.

Obs! Vid nattlig domning som strålar ut i fingrarna (t.ex. karpaltunnelsyndrom), medicinsk undersökning.

AVSNITT 4

Rygg, ryggrad och bål

10 muskler, i atlasens ordning.

27. Trapezius – mellersta fibrer

Musculus trapezius, pars transversa

VAR DU LETAR	Mellan skulderbladets mediala kant och ryggraden, i höjd med spina scapulae, ytligt.
REFERERAD SMÄRTA	mellan skulderbladen, brännande intill ryggraden
PATIENT	Bukläge, armarna längs britsen.
TEKNIK	• Flack kompression med tummen intill skulderbladets mediala kant. • Tvärfriktion över fibrerna.
STRETCH	Armarna korsas framför kroppen, ryggen rundas.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Korrigera hopsjunken sittställning; stretcha bröstmuskulaturen.

28. Trapezius – nedre fibrer

Musculus trapezius, pars ascendens

VAR DU LETAR	Mellan skulderbladets nedre vinkel och ryggraden, mitt på ryggen.
REFERERAD SMÄRTA	nackens baksida, akromion, mellan skulderbladen
PATIENT	Bukläge.
TEKNIK	• Pincettgrepp eller kompression med tummen intill skulderbladets nedre vinkel, på insidan.
STRETCH	Armarna framåt och uppåt, ryggen rundad.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Styrka: lyft armarna i Y-form från bukläge.

29. Serratus posterior superior

Musculus serratus posterior superior

VAR DU LETAR	Under skulderbladets övre del, intill ryggraden; du når den när skulderbladet dras ut åt sidan.
REFERERAD SMÄRTA	djupt under skulderbladet, skuldrans baksida, överarmens baksida, lillfingret
PATIENT	Sittande, armen på den behandlade sidan korsad framför bålen så att skulderbladet glider isär.
TEKNIK	• Flack kompression med fingertopparna mot revbenet, under skulderbladets övre mediala kant. • Korta grepp med lugn andning.
STRETCH	Armen korsad framför kroppen, ryggen rundad.
DOS	2–3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Bukandning i stället för ytlig (snabb) bröstandning.

30. Iliocostalis thoracis

Musculus iliocostalis thoracis

VAR DU LETAR	Cirka 5–8 cm från ryggraden, i mellersta och nedre bröstryggen.
REFERERAD SMÄRTA	mitt på ryggen, buken (ibland), nedanför skulderbladet
PATIENT	Bukläge, en liten kudde under magen.
TEKNIK	• Kompression med tummen vid erector spinaes laterala kant. • Längsgående strykningar nedåt.
STRETCH	Framåtböjning från sittande, med bålen lätt roterad mot motsatt sida.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Rörelsepauser vid långvarigt sittande.

> **Obs!** Vid ryggsmärta tillsammans med buksmärta, feber eller urinvägsbesvär, först läkarundersökning.

31. Iliocostalis lumborum

Musculus iliocostalis lumborum

VAR DU LETAR	I ländryggen, cirka 5–7 cm från ryggraden, nedanför de nedre revbenen.
REFERERAD SMÄRTA	ländryggen, sätesregionen, nedre delen av buken
PATIENT	Bukläge, kudde under magen.
TEKNIK	• Kompression med tummen eller armbågen vid erector spinaes laterala kant.
STRETCH	Ryggliggande med knäna dragna mot bröstet.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Lyft med benen och rak rygg; bryt långvarigt sittande.

Obs! Domningar eller svaghet som strålar ut i benet, påverkad blås- eller tarmfunktion: omedelbart till läkare.

32. Longissimus thoracis

Musculus longissimus thoracis

VAR DU LETAR	2–4 cm från ryggraden, i nedre bröstryggen och övre ländryggen.
REFERERAD SMÄRTA	sätesregionen, ländryggen, höftbenskammen
PATIENT	Bukläge.
TEKNIK	• Kompression med tummen intill ryggraden, nedifrån och uppåt.
STRETCH	Framåtböjning från sittande eller ryggliggande med knäna mot bröstet.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Bryt kontorsarbetet varje timme.

Obs! Vid domningar eller svaghet som strålar ut i benet, läkarundersökning.

33. Multifidus

Musculus multifidus

VAR DU LETAR	Precis intill taggutskotten, djupt, i valfritt segment av ryggraden (oftast i ländryggen).
REFERERAD SMÄRTA	punktformigt intill ryggraden, korsbenet, buken (sällan)
PATIENT	Bukläge, kudde under magen.
TEKNIK	• Djup och långsam kompression med tummen intill taggutskottet, snett riktad inåt.
STRETCH	Ryggliggande med knäna mot bröstet, med lätt rotation åt sidan.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Aktivera det djupa stabiliseringssystemet (dra lätt in magen utan att spänna magmusklerna).

34. Quadratus lumborum

Musculus quadratus lumborum

VAR DU LETAR	Mellan nedersta revbenet och höftbenskammen, vid erector spinaes laterala kant, djupt.
REFERERAD SMÄRTA	höftbenskammen, sätesregionen, höftens sida, ländryggen
PATIENT	Sidoläge med den sida du behandlar uppåt, det övre benet hänger bakåt (utrymmet mellan bäcken och revben öppnas).
TEKNIK	• Kompression med tummen vid erector spinaes kant, inåt mot ryggraden. • Två punkter: nedanför nedersta revbenet och ovanför höftbenet.
STRETCH	Sidoböjning stående eller i sidoläge, med den övre armen över huvudet.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Undvik att stå med vikten på ett ben och att bära väskan bara på ena sidan.

> **Obs!** Smärta i njurtrakten tillsammans med feber eller urinvägsbesvär: först läkarundersökning.

35. Rectus abdominis

Musculus rectus abdominis

VAR DU LETAR	Ovanför och nedanför naveln, 2–4 cm från mittlinjen.
REFERERAD SMÄRTA	vågrätt band mitt på ryggen, buken, ländryggen
PATIENT	Ryggliggande, kudde under knäna.
TEKNIK	• Pincettgrepp eller flack kompression vid muskelns kant.
STRETCH	Ryggliggande med en kudde under ländryggen, armarna över huvudet.
DOS	3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Stretcha efter överdriven magträning.

> **Obs!** Buksmärta med feber, kräkningar eller förändrad avföring eller urin: läkarundersökning, ingen behandling.

36. Obliquus externus abdominis

Musculus obliquus externus abdominis

VAR DU LETAR	På bukens sida, nedanför revbensbågen och ovanför höftbenskammen.
REFERERAD SMÄRTA	bukens sida, ländryggen, nedre bröstkorgen
PATIENT	Rygg- eller sidoläge.
TEKNIK	• Flack kompression med fingertopparna nedanför revbensbågen. • Pincettgrepp på bukens sida.
STRETCH	Ryggliggande med knäna fällda åt motsatt sida, axlarna kvar mot underlaget.
DOS	3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Öka belastningen gradvis i rotationsrörelser.

Obs! Vid bukbesvär ska orsaker från de inre organen uteslutas först.

AVSNITT 5

Bäcken, höft och säte

10 muskler, i atlasens ordning.

37. Gluteus maximus

Musculus gluteus maximus

VAR DU LETAR	I den nedre mediala delen av sätesregionen, intill korsbenet och ovanför sittbensknölen.
REFERERAD SMÄRTA	sätesregionen, korsbenet, runt svanskotan
PATIENT	Bukläge eller sidoläge.
TEKNIK	• Kompression med armbågen eller tummen intill korsbenet och ovanför sittbensknölen.
STRETCH	Ryggliggande, knät dras mot motsatt axel.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Bryt långvarigt sittande; en sittdyna på hårda stolar.

38. Gluteus medius

Musculus gluteus medius

VAR DU LETAR	2–5 cm nedanför höftbenskammen, i den övre laterala delen av sätesregionen.
REFERERAD SMÄRTA	nedre ländryggen, korsbenet, höftens sida, sätesregionen
PATIENT	Sidoläge med den sida du behandlar uppåt.
TEKNIK	• Kompression med tummen nedanför höftbenskammen, framifrån och bakåt.
STRETCH	I sidoläge får det övre benet hänga ner över britsens kant bakom bålen; eller stående med korsade ben och sidoböjning.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Undvik att stå med vikten på ett ben och att sitta med benen i kors; stärk höftens abduktorer.

39. Gluteus minimus

Musculus gluteus minimus

VAR DU LETAR	Djupt under gluteus medius, mellan höftbenskammen och trochanter major.
REFERERAD SMÄRTA	lårets utsida, underbenets utsida, lårets baksida, fotleden
PATIENT	Sidoläge med den sida du behandlar uppåt, det övre knät stöttat.
TEKNIK	• Djup, långsam kompression med tummen eller armbågen ovanför och framför trochanter major.
STRETCH	Ryggliggande, benet korsas över mot motsatt sida.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Bryt långa bilresor och långvarigt sittande.

> **Obs!** Smärtutbredningen påminner om ischias: vid domningar, svaghet eller förändrade reflexer krävs läkarundersökning för att utesluta nervrotspåverkan.

40. Piriformis

Musculus piriformis

VAR DU LETAR	I mellersta och laterala tredjedelen av linjen mellan korsbenets laterala kant och spetsen av trochanter major.
REFERERAD SMÄRTA	sätesregionen, korsbenet, lårets baksida, bakom höftleden
PATIENT	Bukläge, eller sidoläge med det övre knät böjt.
TEKNIK	• Djup kompression med tummen eller armbågen på linjen mellan korsbenet och trochanter major.
STRETCH	Ryggliggande, fotleden på det behandlade benet vilar på det andra knät, det andra låret dras mot bröstet (”fyran”-stretch).
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Sitt inte på plånboken; undvik att sitta med benen i kors.

> **Obs!** Ischiasnerven löper nära: om domningar uppstår, minska trycket; vid ihållande domningar i benet, läkare.

41. Iliopsoas

Musculus iliopsoas

VAR DU LETAR	På lårets framsida nedanför ljumskligamentet (lateralt om femoralisartären) samt i buken, på höftbenets insida.
REFERERAD SMÄRTA	ländryggen intill ryggraden, korsbenet, lårets framsida
PATIENT	Ryggliggande med böjda knän så att bukväggen slappnar av.
TEKNIK	• Under utandning, långsamt flackt tryck med fingertopparna från buken mot höftbenets insida. • På låret, nedanför ljumskligamentet, lateralt om artären.
STRETCH	Utfallssteg (lunge): det bakre knät i golvet, bäckenet skjuts framåt.
DOS	2–3 × 20–30 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Stretching i utfallsposition efter långvarigt sittande.

> **Obs!** Artären löper nära (den pulserar): tryck aldrig på den. Vid bukbesvär och under graviditet ska du inte behandla bukdelen.

42. Tensor fasciae latae (TFL)

Musculus tensor fasciae latae

VAR DU LETAR	På höftens främre laterala del, nedanför spina iliaca anterior superior.
REFERERAD SMÄRTA	lårets utsida, knäts utsida
PATIENT	Rygg- eller sidoläge.
TEKNIK	• Kompression med tummen nedanför och lateralt om höftbenets främre utskott.
STRETCH	I sidoläge får det övre, raka benet hänga bakåt och nedåt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	När du sitter ska höfterna inte vara alltför böjda.

43. Adductor longus och brevis

Musculus adductor longus

VAR DU LETAR	På lårets insida, i den övre tredjedelen.
REFERERAD SMÄRTA	ljumsken, lårets insida, knäts insida
PATIENT	Ryggliggande, knät böjt och fällt ut åt sidan.
TEKNIK	• Pincettgrepp om muskelbuken. • Flack kompression på lårets insida.
STRETCH	Sittande med fotsulorna mot varandra (fjärilen), knäna sjunker nedåt.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Värm upp före snabba sidledsrörelser.

44. Adductor magnus

Musculus adductor magnus

VAR DU LETAR	På lårets bakre insida, i mellersta tredjedelen och nära sittbensknölen.
REFERERAD SMÄRTA	ljumsken, lårets insida, djupt i bäckenet
PATIENT	Ryggliggande med knät böjt och fällt ut åt sidan, eller sidoläge.
TEKNIK	• Flack kompression på lårets bakre insida.
STRETCH	Sittande bredbent, framåtböjning.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Öka belastningen gradvis, värm upp.

> **Obs!** Vid besvär i lilla bäckenet eller gynekologiska besvär, först läkarundersökning.

45. Pectineus

Musculus pectineus

VAR DU LETAR	På lårets främre insida, nedanför ljumskvecket, medialt om femoralisartären.
REFERERAD SMÄRTA	djupt i ljumsken, lårets främre insida
PATIENT	Ryggliggande, benet i lätt abduktion och utåtrotation.
TEKNIK	• Långsamt flackt tryck med fingertopparna nedanför ljumskvecket, medialt om artären.
STRETCH	Benet i abduktion och sträckt, lätt bakåt.
DOS	2–3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	När du sitter ska låren inte pressas ihop.

> **Obs!** Artär, ven och lymfkörtlar i ljumsken ligger nära: arbeta varsamt och tryck aldrig på ett område som pulserar.

46. Sartorius

Musculus sartorius

VAR DU LETAR	Snett över lårets framsida, från höftbenets främre utskott till knäts insida, ytligt.
REFERERAD SMÄRTA	lårets framsida (brännande, stickande känsla), knäts insida
PATIENT	Ryggliggande.
TEKNIK	• Pincettgrepp om det smala muskelbandet, uppifrån och nedåt.
STRETCH	Höften i extension, med lätt inåtrotation (utfallsposition).
DOS	3 × 20–30 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Undvik att sitta länge med benen i kors på golvet (skräddarställning).

AVSNITT 6

Lår, underben och fot

14 muskler, i atlasens ordning.

47. Rectus femoris

Musculus rectus femoris

VAR DU LETAR	På lårets framsida, strax nedanför höften, nära spina iliaca anterior inferior.
REFERERAD SMÄRTA	knäts framsida, runt knäskålen
PATIENT	Ryggliggande.
TEKNIK	• Flack kompression eller pincettgrepp på lårets övre främre del.
STRETCH	Bukläge eller stående, hälen dras mot sätet, höften i extension.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Öka belastningen gradvis i trappor och knäböj (squat).

48. Vastus medialis

Musculus vastus medialis

VAR DU LETAR	På lårets främre insida, 5–10 cm ovanför knät.
REFERERAD SMÄRTA	knäts insida, knäts framsida
PATIENT	Ryggliggande, en liten kudde under knät.
TEKNIK	• Flack kompression med tummen ovanför knät, på insidan.
STRETCH	Knät helt böjt (hälen mot sätet).
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Styrka: sträck ut knät från sittande och håll kvar.

49. Vastus lateralis

Musculus vastus lateralis

VAR DU LETAR	På lårets utsida, på flera ställen mellan höft och knä.
REFERERAD SMÄRTA	lårets utsida, knäts utsida, bakom knäskålen
PATIENT	Sidoläge med den sida du behandlar uppåt.
TEKNIK	• Kompression med armbågen eller tummen på lårets utsida, nedifrån och uppåt.
STRETCH	Knät helt böjt, benet i lätt inåtrotation.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Ligg inte på den ömma sidan.

50. Biceps femoris

Musculus biceps femoris

VAR DU LETAR	På lårets bakre utsida, i mellersta och nedre tredjedelen.
REFERERAD SMÄRTA	knävecket, lårets baksida
PATIENT	Bukläge, kudde under fotleden.
TEKNIK	• Pincettgrepp eller kompression med tummen på lårets bakre utsida.
STRETCH	Ryggliggande, lyft det raka benet med fotleden i dorsalflexion.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Vid långvarigt sittande ska stolskanten inte trycka mot låret.

51. Semitendinosus och semimembranosus

Mm. semitendinosus et semimembranosus

VAR DU LETAR	På lårets bakre insida, i mellersta och nedre tredjedelen.
REFERERAD SMÄRTA	nedre sätesregionen, lårets baksida, knäveckets insida
PATIENT	Bukläge.
TEKNIK	• Pincettgrepp på lårets bakre insida.
STRETCH	Ryggliggande, lyft det raka benet, lätt ut åt sidan.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Värm upp före löpning.

52. Gastrocnemius

Musculus gastrocnemius

VAR DU LETAR	I vadens övre del, på det mediala och laterala huvudet, nedanför knävecket.
REFERERAD SMÄRTA	fotvalvet, vaden, knävecket
PATIENT	Bukläge, kudde under fotleden.
TEKNIK	• Pincettgrepp eller kompression med tummen på båda huvudena.
STRETCH	Stående mot en vägg, det bakre benet rakt, hälen i golvet.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Vid nattliga kramper, stretching på kvällen; tillräckligt med vätska.

> **Obs!** Ensidig svullnad, lokal värme eller rodnad i vaden (misstänkt trombos): ingen massage, omedelbart till läkare.

53. Soleus

Musculus soleus

VAR DU LETAR	I vadens nedre del, djupt under gastrocnemius, ovanför hälsenan.
REFERERAD SMÄRTA	hälen, vaden, korsbenet (sällan)
PATIENT	Bukläge, knät böjt i 90°.
TEKNIK	• Flack kompression från båda sidor i vadens nedre del.
STRETCH	Stående mot en vägg, det bakre knät lätt böjt, hälen i golvet.
DOS	3–5 × 30–90 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Undvik högklackade skor.

Obs! Vid ensidig svullnad eller lokal värme i vaden, ingen behandling: till läkare för att utesluta trombos.

54. Tibialis anterior

Musculus tibialis anterior

VAR DU LETAR	Precis lateralt om skenbenet, i underbenets övre tredjedel.
REFERERAD SMÄRTA	fotledens framsida, stortån
PATIENT	Ryggliggande.
TEKNIK	• Kompression med tummen på muskelbuken, intill skenbenet.
STRETCH	Fotleden och tårna i plantarflexion (sittande med fotryggen mot underlaget).
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20–30 s stretching.
HEMMA	Öka löpbelastningen gradvis; spring mindre på hårt underlag.

Obs! Vid kraftig smärta längs skenbenet som ökar med belastning (misstänkt stressfraktur), läkarundersökning.

55. Peroneus (fibularis) longus

Musculus fibularis longus

VAR DU LETAR	På underbenets utsida, i den övre tredjedelen, 2–4 cm nedanför fibulahuvudet.
REFERERAD SMÄRTA	yttre malleolen, fotens utsida
PATIENT	Sidoläge med den sida du behandlar uppåt.
TEKNIK	• Kompression med tummen på underbenets utsida.
STRETCH	Foten vriden inåt och i plantarflexion.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Stabilitetsövningar för fotleden på ett ben.

Obs! Bakom fibulahuvudet löper nervus peroneus (fibularis): tryck inte där.

56. Tibialis posterior

Musculus tibialis posterior

VAR DU LETAR	Djupt i vaden, bakom skenbenets mediala bakre kant.
REFERERAD SMÄRTA	hälsenan, hälen, fotsulan
PATIENT	Bukläge, knät böjt.
TEKNIK	• Djup, långsam kompression bakom skenbenets mediala bakre kant.
STRETCH	Foten vriden utåt och i dorsalflexion.
DOS	2–3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Lämpligt stöd för fotvalvet; vid plattfot, specialist.

57. Extensor digitorum longus

Musculus extensor digitorum longus

VAR DU LETAR	På underbenets främre utsida, lateralt om tibialis anterior, i den övre tredjedelen.
REFERERAD SMÄRTA	fotryggen, de mellersta tårna
PATIENT	Ryggliggande.
TEKNIK	• Kompression med tummen på underbenets främre utsida.
STRETCH	Tårna och fotleden i plantarflexion.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Undvik trånga skor.

58. Flexor digitorum brevis

Musculus flexor digitorum brevis

VAR DU LETAR	Mitt under fotsulan, framför hälen.
REFERERAD SMÄRTA	mitt under fotsulan, tåbaserna
PATIENT	Bukläge, foten utanför britsens kant.
TEKNIK	• Kompression med tummen mitt under fotsulan. • Långsamma strykningar med en boll eller med en fingerknoge.
STRETCH	Tårna dras uppåt, fotleden i dorsalflexion.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Lämpliga skor; massera fotsulan med en boll.

> **Obs!** Vid skarp hälsmärta vid de första stegen på morgonen (plantar fasciit), läkare eller specialist.

59. Abductor hallucis

Musculus abductor hallucis

VAR DU LETAR	Längs fotsulans mediala kant, mellan hälen och stortåns bas.
REFERERAD SMÄRTA	hälens insida, fotvalvets mediala kant
PATIENT	Sidoläge med insidan av foten du behandlar uppåt.
TEKNIK	• Kompression med tummen längs fotsulans mediala kant.
STRETCH	Stortån dras inåt (mot de andra tårna), fotleden i dorsalflexion.
DOS	3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Skor med bredare tåbox; stärk stortån.

60. Quadratus plantae

Musculus quadratus plantae

VAR DU LETAR	I fotsulans bakre del, djupt, precis framför hälen.
REFERERAD SMÄRTA	hälens undersida
PATIENT	Bukläge, foten utanför britsens kant.
TEKNIK	• Djup, långsam kompression med tummen framför hälen.
STRETCH	Tårna och fotleden i dorsalflexion.
DOS	2–3 × 30–60 s, 3 × 20 s stretching.
HEMMA	Massera fotsulan med en boll, bekväma skor.

Obs! Vid svullnad, domningar eller nattlig smärta i hälen, läkarundersökning.

Nästa steg

Idag: läs de allmänna principerna. **I morgon:** följ protokollet för trapezius och levator scapulae hos nästa patient med nack- eller skuldersmärta och anteckna vad du hittade.